骨折事故を減らすために私たちにできること

子どもの発達と事故予防をどのように両立させるか



駒沢女子短期大学教授
猪熊弘子
INOKUMA Hiroko

２００６年に厚生労働省が初めて保育施設における死亡事故の報告を開始してから、今年で20年経った。[*1] ２０１５年に子ども・子育て支援新制度がスタートすると同時に、特定教育・保育施設における重大事故については自治体を通して国に報告することが義務付けられ、毎年「教育・保育施設等における事故報告集計」[*2]として発表されるようになった。２０２３年からは管轄がこども家庭庁に移り、「教育・保育施設等における事故情報データベース」として整理されて、２０１５年以降のデータが残されている。[*3]

最新のデータは２０２６年７月29日に発表された２０２５年の事故報告集計である。[*4] それによれば、２０２５年１月１日～12月31日までの１年間の死亡事故は１件で、放課後児童クラブのプール活動で発生したものであり、就学前の子どもの教育・保育施設での死亡事故はゼロであった。これは、２００６年に国が調査を開始して以来、初めてのことである。

筆者は２００１年に認可外保育施設で発生した０歳児の死亡事故以来、25年以上ずっと保育事故に関わってきた。事故報告がスタートした当初の２０００年代には毎年10～20人弱の子どもが保育施設で亡くなっていたのだが、20年以上の歳月を経てついにゼロになったのだ。この間、全国の保育施設において保育者の皆さんがどれほどの熱意を持って事故予防に努めてきたことかと思うと胸が熱くなる。今後は放課後児童クラブを含むすべての教育・保育施設での死亡事故がゼロになる日を目指し、ここからがまた新たなスタートとなると言えるだろう。

重大事故の大多数を占めている骨折事故

保育中の「重大事故」は死亡事故だけではない。「重大事故」として国への報告義務があるのは、教育・保育施設等において発生した①死亡事故、②意識不明事故、③治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故であり、これらすべてが「重大事故」と定義されている。例えば２０２５年に報告された「重大事故」３１３０件のうち負傷等が３１２９件あり、その81・０％にあたる２５３３件が骨折であった。過去の調査においても同様で、２０１５年に報告された負傷等４６１件のうち０～５歳の子どもに関する３４７件の事故について分析したところ、ケガの種類としては「骨折」が最も多く、３４７件中２６０件と全体の74・９％を占めていた（猪熊 ２０１８）。[*5]

「骨折」は決して軽いケガではない。骨折の治療には通常30日以上かかるため、国の定義に従えば必然的に「重大事故」となる。「重大事故」を防ぐという観点からも、園におけるケガ予防

の目標を「骨折以上のケガを防ぐ」としておくとよいだろう。

その「骨折」に特化した報告書『令和7年度子ども・子育て支援調査研究事業　教育・保育施設等における骨折事故防止対策に関する調査研究事業報告書』が2026年3月に発表された（株）日本経済研究所[*6]。報告書の中では、これまでに国の事故情報データベースに蓄積された骨折事故について、年齢、施設種別、発生月、活動状況、受傷部位、事故誘因、職員の動きなどについての集計と分析が行われており、骨折事故に関する特徴が明らかにされている。

それによれば、まず、骨折事故は女児よりも男児に多く、年齢では3～6歳の幼児から小学校低学年に集中している。発生時期としては、戸外での活動が増える3～4月、9～11月に多い。受傷部位は腕・手・手指などの上肢が多く、転倒や衝突、遊具からの落下の際に手をついて骨折していると考えられる。

さらに施設種別と年齢を組み合わせたクロス集計からは、認可保育所・幼保連携型認定こども園では3～6歳、放課後児童クラブでは6～9歳に多いこと、施設種別・年齢・事故誘因を重ねたクロス集計からは、保育所・認定こども園の幼児では「遊具からの転落・落下」が多く、保育所・認定こども園の幼児から放課後児童クラブの低学年では「自らの転倒・衝突」が多いことが明らかにされている。

子ども同士の関わりの中での事故を防ぐには？

報告書のデータの中で特に注目したのは、子ども同士の関わりの中で起きた骨折事故である。事故誘因が「子ども同士の衝突」とされる事故は毎年全体の9～10％程度あり、2023年度は185件（10・3％）、2022年度は141件（9・4％）、2021年度は130件（9・2％）、2020年度は135件（9・6％）であった。さらに事故誘因が「他児から危害を加えられたもの」は別に集計されており、2023年度28件（1・6％）、2022年度43件（2・9％）、2021年度29件（2・1％）、2020年度27件（1・9％）あった。単純に遊具から落下したり、自ら転倒したりするだけでなく、子ども同士の関わりが誘因となる骨折事故がこれだけあるということだ。

子どもの転倒や遊具からの落下を防ごうという視点は重要だが、それだけで骨折事故を防ぐことは難しい。子ども同士が互いの関わりの中で成長していくのが保育であり、関わりを制限したり止めたりすることは不可能である。そのため、骨折事故を100％防ぐことは不可能だとも言える。それでもできる限りの事故を防ぐためには、保育者は日々の保育の中で子ども一人一人の特性や子ども同士の関係性を十分に理解し、子ども同士の関わりがスムーズにいくように環境を構成することが必要だ。そのうえで子どもの思いや願いを受け止めるために、子どもの声を聞きながら保育を行っていかなければならない。

以前、「ケガが多くて困っている」という園に行ったことがある。室内で子ども同士がふざけ合っているうちにぶつかって骨折したという話を聞いて予想していた通り、その園の保育室では机や椅子が壁側に片づけられ、中央に広いスペースだけが確保されていた。子どもたちの興味を引くようなコーナーや絵本を読むスペースもなかった。子どもたちは保育室の中で走り回る以外にやることがないため、ひたすら走り回り、保育者が厳しい言葉をかけて制止するという悪循環になっていた。保育室に続く広い廊下もきれいに掃除されていたが、やはり子どもの興味を引くようなものは何もなく、子どもたちが走り回るしかない環境だった。

さらに、外部講師による「体育指導」の中でも骨折事故が起きたと聞いて驚いた。骨折するほどの指導が必要なはずはない。子どもが動きを止めてじっくり遊びたいと思える魅力的な遊びの要素がないうえに、子どもの発達を無視した無理な活動が行われていれば、骨折事故が起きるのも当然のことである。「目の前が開けたところに行けば走る」という、子どもの一般的な特性を知ったうえで保育室内外の環境を整

え、クラスの子どもたち一人一人の発達や興味、願いに沿った活動を行っていくことで、不必要な骨折事故を防げるようになるはずである。

挑戦の結果の骨折をどう考えるか

実は何を隠そう私自身も、幼稚園・認可保育所の副園長をしていた時代に一人の子どもが骨折し、国への報告書を書いた経験がある。ちょうど年度替わりの3月末、年長クラスへの進級を数日後に控えた年中の男児X君（当時5歳）が、園庭の鉄棒から落ちて手を付き、手首を骨折してしまったのだ。その日、私は不在で、保育者が誰もその現場を見ていなかったこともあり、後で保護者からお叱りを受けた。

男の子は全治2か月という診断で、私が区を通して国への報告書を書いたのだが、まずは「鉄棒」について区の担当者と意見が食い違った。担当者は「鉄棒は危険な遊具です。なぜ鉄棒に誰も付いていなかったんですか?」と言ったが、園庭にはもっと高さがある危険な遊具がある。「うちの園庭をご存じですよね? あの中では鉄棒は危険な遊具には入りません」と説明したが、担当者は「鉄棒は危険な遊具だ」と言い続ける。私は「鉄棒に人を付けろというなら、先生の数が足りません!」と言い、結局最後まで意見がかみ合わなかった。

当初、全治2か月という診断を受けていたX君だが、予想よりもずっと治りが早く、1か月を過ぎた頃にはギプスを外すことができていた。その頃、たまたまX君と二人で話す機会があり、私は率直に尋ねてみた。

「ねえ、X君はどうしてあの時、鉄棒から落ちちゃったの?」

彼の返答は意外なものであった。

「あの時ね、足かけ前回りをしていたんだよ。いつもは右足をかけて回っていたんだけど、その日は反対の足でもできるような気がしてやってみたんだ。そしたら落ちちゃったんだよ」

驚いたことに、彼は自分のケガの原因を理解していた。

「そうだったんだ。とても痛くて、辛かったよね。でもあなたはあの時、挑戦していたんだね」

「うん」

彼は大きく頷いた。骨折したことは彼にも保護者の方にも申し訳なく、私たちに大きな責任があることは変えられないが、彼自身が挑戦した結果の骨折だったと知ることができた。数日後、お迎えの際にX君の母親にお会いすることができたので、その話を伝えてみた。母親はとても驚いた表情で言った。

「家ではそんな話はしてくれなかった。今、初めて聞きました。ありがとうございます」

骨折が当初の診断よりも早く治ったことで気持ちも落ち着いていたのだと思うが、母親は笑顔だった。そしていつもおとなしいX君が、そのように冷静に自分のケガの原因について話したことに驚いた。骨折は絶対に避けたいケガであり、一般化できることではないが、この時のケガは、次にX君自身がケガをしないための学びにつながったとも考えられる。

100%リスクのない世界は子どもによくない

私はこれまで、日本とイギリスなど海外の保育の中での子どもの遊びとケガについて調査してきたが、話を聞いたすべての保育者が「子どもの発達を守りたい」という思いと「子どものケガを防ぎたい」という思いの間で揺れていた。ただ、方向性としては、子どもの安全について研究しているカナダ人研究者Brussoniの「子どもの安全を守るために、傷害予防は重要な役割を担っている。しかし、最近の研究では、子どもの屋外での危険な遊びを制限しすぎることは、子どもの発達を妨げることが示唆されている」（Brussoni,et al.2012）という言葉が示すように、多少の危険があったとしても、子どもの発達を守ることを大切にする方向に行っているように感じる。

例えば、Risky Play（危険のある遊び）[*7]の伝統があるノルウェーの幼稚園では、国連子どもの

権利条約に基づいて「幼稚園法」という法律が定められ、子どもが民主的な市民として生きるための最初の社会としての幼稚園の意義や活動について示されている。日本の保育所保育指針や幼保連携型認定こども園教育・保育要領に相当する「幼稚園の枠組み計画」の中では「幼稚園は、子どもたちが身体的な挑戦を通して、危険な遊びを経験し、評価し、習得する機会を持つようにしなければならない」（ノルウェーの幼稚園の枠組み計画 2017：49）と定められている。これは、国連子どもの権利条約第31条「遊びと余暇の権利」に基づくものであり、危険な遊びも子どもが生きるための重要な要素であり、権利の一つと考えられている。

2年前に実際にノルウェーの幼稚園に調査に行ったが、園庭に子どもにとってわざわざ危険な場所をつくるのではなく、「危険がゼロではない」と言える環境の中で保育を行っていた。「可能な限り安全」なのではなく、「必要な限り安全」であることが求められているのである。

考えてみれば、私たちが生きている社会は100％安全とは言えない。子どもがケガをしない方がよいが、まったくケガをせずに育つことはできないのが現実である。絶対にケガをさせないためには、子どもを箱にでも入れて育てるしかない。「100％リスクのない世界は子どもにとってよくない」という当たり前のことを、保育者、保護者だけでなく、社会がどのように理解するかが問われている。

保育の安全のために必要なのは「子ども理解」

骨折事故の予防に必要なのは、事故がどのような場面で起きるかを知って対策を立てること、そして一人一人の子どもの理解をするかである。例えば、さまざまな調査から最も事故の多い遊具はすべり台だと判明しているので、保育者は必ずすべり台に向かって立つ必要がある。保育者は、ただなんとなく均等な位置に立つのではなく、子どもの年齢、人数、保育者の数、危険な遊具の場所から、あらかじめ立ち位置を決めておくべきだ。基本的に子どもは発達するからケガをする。寝ているだけの赤ちゃんはケガをすることはないが、寝返りができるようになるとベッドから落ちる可能性が出てくる。立っちできるようになれば倒れるし、歩けるようになれば転ぶ。保育者は、自分のクラスの子どもたち一人一人が現在どのように発達しているのかをしっかり見極めたうえで、子どもたちが自然に立ち止まり、じっくり遊べる環境をつくっていくことで、子どもの危険な動きを自然に止めることができるのである。

骨折事故の報告書では、骨折事故が起きた施設の多くで、事故防止マニュアルの整備や研修の実施、設備や遊具の点検、基準を満たした職員配置が行われていたことも明らかになっている。事故発生時に担当職員が子どもを見ていたケースも多く、いくら見守りに力を入れても防ぎきれない事故もある。有識者からの意見としても、骨折事故をすべてゼロにすることは現実的には難しいことが指摘されている。

だからといって、骨折をしてよいというわけではない。骨折は絶対に防ぎたい。そのためにできることは、ただの見守りではなく、子どもの発達と気持ちを十分にふまえた環境づくりをしていくことである。それは同時に保育の質の向上につながっていく。安全は保育の質に直結しているのである。

［註］
＊1　2006年には、2004年分から遡って発表した。
＊2　「教育・保育施設等における事故報告集計」の公表等について
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/effort/shukei
＊3　https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/effort/database/
＊4　https://x.gd/Suvqn
＊5　猪熊弘子「就学前の子どもの施設における事故の特徴―「遊び」に着目して　内閣府「特定教育・保育施設等における事故情報データベース」の分析から」『子ども安全研究』第3号，pp.18-21
＊6　https://x.gd/xgA6h
＊7　ノルウェーの子どもの1～5歳までの90％以上が通う施設。朝7時半～夕方5時まで開園しており、おやつや給食、お昼寝もある。「幼稚園」と訳されるが、実際には日本の保育所や幼保連携型認定こども園とよく似ている。